

Elukvaliteedi mõõtmine eri tüüpi eluasemeteenuste puhul

Üks võimalik viis deinstitutionaliseerimise tulemuste mõõtmiseks vaimse tervise valdkonnas



Zsolt Bugarszki

sotsiaalpoliitika lektor, Tallinna Ülikool

Deinstitutionaliseerimine on Eestis jõudnud etappi, kus vaimse tervise probleemidega inimestele luuakse teenuseid, mis võimaldavad neil elada kogukonnas. Artikkel kirjeldab viise, kuidas mõõta erinevate vaimse tervise valdkonna teenuste mõjusust ja kulutõhusust, ning tutvustab teistes riikides läbi viidud uuringute tulemusi, kus võrreldi erinevaid toetatud eluasemeteenuseid.

Meditšiinis mõõdetakse ravi tulemuslikkust üldjuhul kliiniliste uuringutega, mille metoodika on rangelt kontrollitud (Kassier 1993). Traditsioonilised kliinilised uuringud keskenduvad haiguse tekkega seotud asjaoludele, patoloogilistele, bioloogilistele, füsioloogilistele ja kliinilistele tulemustele. Tänu toimivale paradigma muutusele on suurenenud sotsiaalteaduste mõju vaimse tervise alastele uuringutele – tähelepanu all on ka funktsioneerimisvõime, üldine heaolu ning sotsiaalse ja institutsionaalse konteksti olulisus. (Orley ja Kuyken 1993)

Vaimse tervise uuringud muutuvad inimesekesksemaks

Ka Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi WHO, ingl *World Health Organisation*) põhikirja järgi on tervis *täielik füüsilise,*

vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või puude puudumine (RT, 2005, II, 4, 11). Seega tuleb tervise ja tervishoiu mõjude mõõtmisel lisaks haiguste esinemissagedusele ja raskusastmele võtta arvesse ka inimeste hinnanguline heaolu ehk elukvaliteedi paranemine. Elukvaliteet WHO järgi on *inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus tema väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese ootuste, eesmärkide, elustandardite ja tajutud probleemidega.* (WHO 1997) Seega iga kord, kui tervishoiu- ja hoolekandeteenuste osutajad hakkavad rakendama mõnda uut poliitikat, on oluline analüüsida nende poliitikamuudatuste mõju teenusekasutajate elukvaliteedile.

Esimene suurem muutus vaimse tervise alastes uuringutes ilmnes, kui WHO töötas välja tervikliku elukvaliteedi mõõtmise instrumendi. WHOQOL100 ja selle lühem

versioon WHOQOL-BREF jagab elukvaliteedi kuueks valdkonnaks: füüsiline tervis; psühholoogiline heaolu; iseseisvuse tase; sotsiaalsed suhted; keskkond; spirituaalsus, religioon ja isiklikud uskumused. (*ibid*) Nagu näha, sisaldab see nii traditsiooniliste kliinilise uuringute füsioloogilisi ja psühholoogilisi aspekte kui ka kaasaegse sotsiaalteaduse mõõdet. Alates 90. aastatest on loodud teisi instrumente erinevate sihtgruppide elukvaliteedi mõõtmiseks (vt näiteks Becker jt 1993, Greenly jt 1997, Pesola jt 2015).

Teenuste osutamine ja sotsiaaltöö meetodid muutuvad aina enam inimese- ja teenusekasutajakesksemaks, samasugused muudatused toimuvad ka uurimismeetodites ning tulemusmõõdikutes. Vaimse tervise teenuste tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse endiselt kliiniliste ja sotsiaalsete mõjude mõõtmist, kuid seejuures uuritakse üha sagedamini teenusekasutajate vaatenurka, selmet kasutada spetsialistide loodud mõõtmisinstrumente. Olemasolevaid elukvaliteedi mõõtmise instrumente arendatakse üha edasi. Nii võibki öelda, et tulevikus on teenuste tulemusmõõdikud veelgi individuaalsemad ja inimesekesksemad.

Ühendkuningriigi näide: kogukonnapõhised teenused annavad paremaid tulemusi

Anthony (1993) väidab, et minevikus põhinesid vaimse tervise teenuste süsteemid uskumusel, et raske psüühikahäire all kannatavatel inimestel ei ole võimalik taastuda. Nüüdseks teame, et kliinilise paranemise vaatenurgast ei vasta see tõele (Warner 2009). Alates 1990. aastatest on üha mõjukam taastumisliikumine, mis on laienenud teenusetarbijate rühmadest spetsialistide rühmadeni ja seejärel ka riikliku poliitika kujundamise mõjutamiseni enamikus kõrge sissetulekuga riikides. Taastumisel põhinevate

lähenemiste puhul keskenduvad vaimse tervise spetsialistid üksikisikule ja tema kogemustele, tunnustatakse isiku tugevaid külgi ja tema ressursse. Teenusekasutajaid võetakse kui oma kogemusele tuginevaid eksperte. Rõhku pannakse inimeste isiklikele pingutustele saamaks kontrolli oma haiguse üle ja õigusele püüelda eesmärkide poole, mida väärtustavad nemad ise, mitte spetsialistid ja hooldajad, kelle sihid ja ootused võivad olla madalamad (Shepherd jt 2008).

Teenuste tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse endiselt kliiniliste ja sotsiaalsete mõjude mõõtmist, kuid seejuures uuritakse üha sagedamini teenusekasutajate vaatenurka.

Ühendkuningriigis on haiglakohtade vähendamine ja üleminek kogukonnapõhistele teenustele edukalt lõpule jõudnud. Enamikus piirkondades pakutakse rehabilitatsiooniteenuste raames endiselt lühiajalist ja keskmise kestusega ööpäevaringset öendusteenust (Killaspy jt 2005), kuid endised haiglate pikaajased patsiendid on liikunud kogukonnas pakutavatele teenusele. Suured psühhiaatriaiglad on asendatud mitmekesise kogukondlike teenuste võrgustikuga (Holloway 2008). Uuringud näitavad, et üldiselt on see muudatus inimeste olukorda parandanud: kogukonda elama asunud inimesed on eluga rohkem rahul, nende sotsiaalne toimetulek on paranenud ning kulutused ei ole suuremad kui haiglas olles: üldjuhul on kulud pigem väiksemad (Trieman ja Leff 2002; Thornicroft ja Tansella 2005). Leidub rohkelt tõendusi selle kohta, et Inglismaal (tagasi) kogukonda elama asunud inimestel on parem elukvaliteet, nende vaimne tervis on stabiilsem, neil esineb vähem tagasilangusi

ning nad on pakutavate teenustega rohkem rahul (Leff jt 2000). Sarnaste tulemusteni on jõudnud pikaajalised uuringud Austraalias, Ameerika Ühendriikides, Norras ja Itaalias (Shepherd ja MacPherson 2011).

Erinevate toetatud eluasemeteenuste mõju elukvaliteedile

Paljudele vaimse tervise probleemidega inimestele on sobiv eluase ja toetus hoolekande võtmelemendid, ning eluasemel on nende elukvaliteedile suur mõju. Enamikus riikides on deinstitutionaliseerimise järel loodud lai valik kogukonnapõhiseid teenuseid, mis pakuvad inimestele nii toetust kui ka eluaset.

Leff jt (2009) viisid läbi 30 uuringu metaanalüüsi, et võrrelda erinevat tüüpi toetatud eluasemeteenuste mõju inimeste tervist ja toimetulekut iseloomustavatele tulemusnäitajatele.

Autorid jaotasid need väljaspool hoolekande- ja raviasutusi pakutavad teenused kolmeks mudeliks:

- elamine teenuseosutaja ruumides koos pikaajalise hoolduse ja rehabilitatsiooniga
- elamine teenuseosutaja ruumides koos teineteisele järgnevate tugiteenustega
- elamine üüritava sotsiaaleluasemel koos paindlike tugiteenustega.

Neid teenusemudeleid võrreldi tavapärase eluasemeteenuseta tugiteenuste pakkumisega.

Pikaajalise hoolduse ja rehabilitatsiooniga seotud eluasemeteenuste mudel viitab teenustele, mille raames teenuseosutaja pakub inimesele järelevalvega eluruume ja toitlustust, nagu elamine rühma- või perekodus. Tugiteenuseid pakutakse kohapeal, inimeselt eeldatakse sõltuvusainete tarvitamisest hoidumist. Eestis rakendatakse seda mudelit sageli kogukonnas elamise teenuse pakkumisel, mille kliendid elavad küll kogukonnas asuvates

peremajades, kuid on tegelikult ikkagi ühiskonnast eraldatud.

Teineteisele järgnevate tugiteenustega eluasemeteenus langeb kohati eelmainituga kokku, kuid viitab siiski uuemale mudelile. Inimene saab taastumise käigus samas elukohas järjestikku erinevaid toimetulekut ja iseseisvust toetavaid tugiteenuseid, iga järgmine teenus pakub talle üha rohkem iseseisvust.

Paindlike tugiteenustega sotsiaaleluruumid võimaldavad teenustekasutajatel jääda iseseisvaks ning säilitada suhted ümbritsevate inimestega, kuna eluasemeteenus sarnaneb pigem tavalise elamispinna üürimisega. Vajalikud tugiteenused on kättesaadavad paindlikult ja vastavalt vajadusele, personal pakub teenuseid siis, kui klient seda soovib.

Eluasemeteenuseta tugi tähistab tavapärasest hoolekannet ning viitab uuringutele, milles ei viidatud ühelegi kindlale eluaseme liigile. Klient elab oma kodus, kuid saab tugiteenuseid, mis pole eluasemega seotud (näiteks rehabilitatsioonimeeskonnalt, ambulatoorset psühhiaatrilist abi, sotsiaaltöötaja tuge).

Autorid leidsid, et kõige vähem stabiilsust tagas inimestele eluasemeteenuseta tugi ja parima tulemuseni jõudsid inimesed, kes kasutasid paindlike tugiteenustega sotsiaaleluruume. Võrreldes eluasemeteenuseta toega vähenesid vaid pikaajalise hooldus- ja rehabilitatsiooniteenusega eluaseme puhul psühhiaatrilised sümptomid, kuid siiski tõid kõik eluasemeteenustega tugiteenuste liigid kaasa haiglaravi vajavate juhtude arvu vähenemise, mis viitab sellele, et inimeste igapäevane toimetulek on paranenud. Klientide rahulolu oli kõrgeim paindlike teenustega sotsiaaleluruumide kasutajatel.

Sarnaste tulemusteni jõudsimise ka Ungaris läbiviidavas uurimuses, kus mõõdeti erinevate sihtgruppide elukvaliteeti kolme erineva eluaseme vormi puhul. Nendeks vormideks olid **hooldekodud, rühmakodud ja isiklikud**

kodud (peamiselt elati koos pereliikmetega). Uurimus näitas, et parim elukvaliteet saavutati rühmakodudes, kus elanikele oli tagatud piisav professionaalne toetus, kuid nad said hooldekodudes elavatest inimestest enam nautida iseseisvust ja kontrolli oma elu üle. Peredega koos elavad inimesed olid kõige enam kaasatud oma kogukondadesse, kuid vajaliku toetuse vähesuse tõttu oli nende elukvaliteet madalam kui inimestel, kes elavad kogukonna tugiteenustega majutusasutustes. (Kopasz jt 2016)

Paljudele vaimse tervise probleemidega inimestele on sobiv eluase ja toetus hoolekande võtmelemendid, ning eluasemel on nende elukvaliteedile suur mõju.

Paljudele vaimse tervise probleemidega inimestele on sobiv eluase ja toetus hoolekande võtmelemendid, ning eluasemel on nende elukvaliteedile suur mõju. Maailma eri paigus teostatud uuringud on järjepidevalt näidanud, et teenusekasutajad eelistavad suuremat iseseisvust pakkuvat tavalist eluaset ja personaliga koos elamise asemel pigem paindlikku, nende oma kodus pakutavat tuge (Tanzman 1993; Owen jt 1996; Hogberg jt 2006). Uuringutes on rõhutatud ka toetatud eluasemeteenustega seotud valikuvõimaluse olulisust. Ameerika Ühendriikides läbi viidud Srebnik jt uuring (1995) näitas, et suurem tajutud valikuvõimalus oli seotud rahulolu kasvuga aasta hiljem. Sarnased tulemused ilmnesid Kanadas läbi viidud longituuduuringus, kus Nelson ja kolleegid (2007) leidsid, et valikuvõimalused ja kontroll eluaseme üle parandasid elukvaliteeti, kusjuures omaette korteris elamine suurendas valikuvõimalusi, kontrolli ja tuge võrreldes peremajas elamisega.

Erinevate eluasemeteenuste mõju analüüsimise vaimse tervise probleemidega inimestele kogukonnas muudab raskeks mitte üksnes asjakohaste andmete vähesus, vaid ka kohalike kogukondade keerukas kontekst.

Sotsioloogiale omane kaasaegne võrgustike analüüs toob meid lähemale lahendusele, milles tulemused ei põhine vaid kliinilisel seisundil ja hoolduse üksikasjadel, vaid uuringud võtavad arvesse ka selliseid mõõtmeid nagu naabruskonna kvaliteet (Jones-Rounds jt 2013; Shiue 2015), kohalike kogukondade sotsiaal-majanduslikud omadused (Ludwig jt 2012) ja haavatavate rühmade olukord linnaarengu tingimustes (Rogers jt 2008).

Kokkuvõte

Sotsiaalteadused avaldavad märkimisväärset mõju vaimse tervise valdkonnas kasutatavatele tulemusmõõdikutele. Traditsioonilisi kliinilisi uuringuid kasutatakse tänapäeval kombinatsioonis laiaulatuslike elukvaliteedi mõõtmise vahenditega, mis on inimesekesksemad ja tundlikumad kogukondade kultuuriliste ja sotsiaal-majanduslike kontekstide suhtes.

Rahvusvaheliselt ei kahelda enam selles, et kogukondades paiknevad toetatud eluasemeteenused võimaldavad vaimse tervise probleemidega inimestele kõrgemat elukvaliteeti kui erihooldekodud ja haiglad. Kuid hetkel on veel vähe uurimusi ja metodoloogilisi probleemipüüsi, mis võimaldaksid võrrelda omavahel erinevaid kogukonnas pakutavaid eluasemeteenuseid.

Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et rohkem iseseisvust lubavad, kuid siiski tugiteenustega toetatud eluasemeteenused on kõige tõhusamad ning tagavad kasutajate suurema rahulolu. Valikuvabadus, kontroll teenuste disaini üle ja teenusekasutaja osalemine otsustusprotsessis on rahuolu võtmelemendid. Samas saavutatakse enami- kus eluvaldkondades paremaid tulemusi, kui

iseseisvust toetab vajadusel põhinev aktiivne tugi.

Eestis oleks äärmiselt tähtis seada sisse analüüsisüsteem, millega mõõta järjepidevalt käimasoleva deinstitutionaliseerimise tulemusi. Tarvis on uurida, mis võimalusi pakuvad erinevad kogukonnad puuetega inimeste ja vaimse tervise probleemidega inimeste loimimiseks. Samas tuleb selgitada

välja ka see, mis tasemel toetus ja iseseisvus oleks eri sihtgruppide puhul optimaalne. Erialasest kirjandusest saab olulist informatsiooni teiste riikide kogemustest, mille põhjal on meil võimalus leida kohalikke tõhusaid lahendusi. **S**

Tõlge inglise keelest: Tiido ja Partnerid Keeleagentuur / ajakiri Sotsiaaltöö

Viidatud allikad

- Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health service system in the 1990's. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16, 11–23.
- Becker, M., Diamond, R., Sainfort, F. (1993). A new patient focused index for measuring quality of life in persons with severe and persistent mental illness. *Quality of Life Research*, 2 (4), 239–251.
- Greenley, J. R., Greenberg, J. S., Brown, R. (1997). Measuring Quality of Life. A New and Practical Survey Instrument. *Social Work*, 42 (3), 244–254.
- Hogberg, T., Magnusson, A., Lutzen, K. (2006). Living by themselves? Psychiatric nurses' views on supported housing for persons with severe and persistent mental illness. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing* 13, 735–741.
- Holloway, F. (2008). The community psychiatrist in 2008: anachronism, Cinderella or pioneer? *The Psychiatrist*, 32, 161–163.
- Jones-Rounds, M. L., Evans G. W., Braubach, M. (2014). The interactive effects of housing and neighbourhood quality on psychological well-being. *Journal Of Epidemiology And Community Health*, 68 (2), 171–175.
- Kassirer, J. P. (1993). Clinical trials and meta-analysis. What do they do or us? *New-England Journal of Medicine*, 327, 273–274.
- Killaspay, H., Harden, C., Holloway, F., King, M. (2005). What do mental health rehabilitation services do and what are they for? A national survey in England. *Journal of Mental Health*, 14: 157–165.
- Kopasz, M., Simonovits, B., Kozma, Á., Bernát, A., Verdes, T., Bugarszki, Z. (2016). Quality of Life and Costs of Living and Services of Disabled People. Teoses: Various Residential Arrangements in Hungary. Budapest: TÁRKI Social Research Institute, Budapest.
- Leff, J., Trieman, N., Knapp, M., Hallam, A. (2000). The TAPS Project: a report on 13 years of research, 1985–1998. *Psychiatric Bulletin*, 24, 165–168.
- Leff, H. S., Chow, C. M., Pepin, R., Conley, J., Allen, I. E., Seaman, C. A. (2009). Does one size fit all? What we can and can't learn from a meta-analysis of housing models for persons with mental illness. *Psychiatric Services*, 60, 473–482.
- Ludwig, J., Duncan, G. J., Gennetian, L. A., Katz, L. F., Kessler, R. C., Kling, J. R., Sanbonmatsu, L. (2012). Neighborhood effects on the long-term well-being of low-income adults. *Science*, 337 (6101), 1505–1510.
- Maaailma Terviseorganisatsiooni põbikiri*. (2005). Riigi Teataja II, 4, 11.
- Nelson, G., Sylvestre, J., Aubry, T. (2007). Housing choice and control, housing quality, and control over professional support as contributors to the subjective quality of life and community adaptation of people with severe mental illness. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 34, 89–100.
- Orley, J., Kuyken, W. (1993). Quality of Life Assessment: International Persepectives. Berlin: Springer Verlag, 41–57.

- Owen, C., Rutherford, V., Jones, M., Wright, C., Tennant, C., Smallman, A. (1996). Housing accommodation preferences of people with psychiatric disabilities. *Psychiatric Services*, 47, 628–632.
- Pesola, F., Williams, J., Bird, V., Freidl, M., Le Boutillier, C., Leamy, M., MacPherson, R., Slade, M. (2015). Development and evaluation of an Individualised Outcome Measure (IOM) for randomised controlled trials in mental health. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 24 (4), 257–265.
- Rogers, A., Huxley, P., Evans, S., Gately, C. (2008). More than jobs and houses: mental health, quality of life and the perceptions of locality in an area undergoing urban regeneration. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 43 (5), 364–369.
- Shepherd, G., Boardman, J., Slade, M. (2008). Making Recovery a Reality. Sainsbury Centre for Mental Health.
- Shepherd, G., MacPherson, R. (2011). Residential care. Teoses: Thornicroft, G., Szmukler, G., Mueser, K. T. (toim.). *Oxford Textbook of Community Mental Health*. Oxford University Press, 178–187.
- Shiue, I. (2015). Neighborhood epidemiological monitoring and adult mental health: European Quality of Life Survey, 2007–2012. *Environmental Science and Pollution Research*. 22 (8), 6095–6099.
- Srebnik, D., Livingstone, J., Gordon, L., King, D. (1995). Housing choice and community success for individuals with serious and persistent mental illness. *Community Mental Health Journal*, 31, 139–152.
- Tanzman, B. (1993). An overview of surveys of mental health consumers' preferences for housing and support services. *Hospital and Community Psychiatry*, 44, 450–455.
- Thornicroft, G., Tansella, M. (1999). Translating ethical principles into outcome measures for mental health service research. *Psychological Medicine*, 29, 761–767.
- Trieman, N., Leff, J. (2002). Long-term outcome of long-stay psychiatric inpatients considered unsuitable to live in the community: TAPS Project 44. *British Journal of Psychiatry*, 181, 428–432.
- Warner, R. (2009). Recovery from schizophrenia and the recovery model. *Current Opinion in Psychiatry*, 22, 374–80.
- World Health Organization (1997). WHOQOL Measuring Quality of Life. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. World Health Organization.